01 • Circuit du médicament

À APPRENDRE • Le fil conducteur du CM (diapos 3, 14–18)

4 ÉTAPES À RETENIR

1. PRESCRIPTION : décision thérapeutique, ordonnance.
2. DISPENSATION : analyse du pharmacien, mise à disposition.
3. ADMINISTRATION : contrôles, préparation, prise, traçabilité.
4. SUIVI : efficacité, tolérance, observance, réévaluation.

TRANSPORT • STOCKAGE • PUI

Transport sécurisé entre PUI et service ; respect de la chaîne du froid.

PUI = pharmacie à usage intérieur ; le livret thérapeutique recense les médicaments retenus.

EN STAGE

Vérifier le mode de dispensation, la personne qui prépare le pilulier, l’emplacement des stocks et les alertes à la PUI.

02 • Prescription conforme

VERSO DE LA FICHE 01 (diapos 4–13)

CONTRÔLES AVANT ADMINISTRATION

Prescripteur identifié, date, signature / validation ; patient identifié.

Médicament : DCI, forme, dosage, voie, posologie, fréquence, durée.

Préciser conditions « si besoin » et limites ; ne rien deviner.

QUATRE ORDONNANCES DU COURS

Classique • sécurisée • bizone (ALD) • médicaments d’exception.

Les droits de prescription dépendent des professions et du cadre légal.

PRESCRIPTION AMBIGUË

Suspendre la prise concernée, faire confirmer par le prescripteur et tracer les démarches. CSP R.4312-42.

03 • Droit de prescription IDE

RECTO • Réglementation 2026 (diapos 5–6, 28–33)

LES TEXTES DISTINCTS

Arrêté 20/02/2026 : référentiel du diplôme, compétences 3 et 4.

CSP R.4311-2 : interventions, surveillance et prescriptions autorisées.

Arrêté 26/06/2026 « prescription » : liste de produits / examens et conditions.

DOMAINES ÉVOQUÉS EN CM

Vaccination, plaies, santé sexuelle / contraception, sevrage tabagique, produits de santé, certains examens biologiques.

NE PAS SURINTERPRÉTER

Ces rubriques n’autorisent pas toutes les prescriptions. Vérifier les annexes et conditions avant chaque acte.

04 • Stockage sécurisé

VERSO • Dispensation et conservation (diapos 17–25)

TYPES DE DISPENSATION

Nominative (patient défini) • globalisée (service).

Réassort de dotation (armoire) • rétrocession (patient externe autorisé).

À CONTRÔLER

Date de péremption, intégrité, étiquettes, température, humidité, lumière et emballage d’origine.

Armoire sécurisée, stupéfiants sous contrôle, traitements personnels selon procédure.

ALERTE EN STAGE

Produit non identifiable, cassé, périmé ou rupture de chaîne du froid ? Ne pas administrer. Prévenir l’IDE / PUI.

05 • Règle des 5 B

RECTO • Administration (diapos 27, 34–39)

LES 5 B • HAS

Bon patient : concordance identité / prescription / produit.

Bon médicament : DCI, forme, dosage, intégrité, allergie.

Bonne dose : calcul cohérent, concentration vérifiée.

Bonne voie : voie prescrite, forme compatible.

Bon moment : heure, intervalle, interaction / repas si besoin.

SÉCURITÉ RENFORCÉE

Double contrôle selon protocole (insuline, opioïdes, anticoagulants, KCl concentré...). Éviter interruptions et confusion de patients.

MNÉMO

Pa • Mé • Do • Vo • Mo = Patient, Médicament, Dose, Voie, Moment.

06 • Rôle IDE et traçabilité

VERSO • Avant / pendant / après (diapos 27, 36, 40)

AVANT

Prescription valide ; allergies ; clinique pertinente ; paramètres vitaux / biologie selon médicament ; information du patient.

PENDANT

Vérifier les 5 B ; hygiène ; bonne technique ; ne pas broyer / ouvrir une forme sans vérification.

APRÈS

Tracer réellement médicament, dose, voie, heure ; tracer refus, retard, omission et motif. Surveiller efficacité et effets indésirables.

JAMAIS

Administrer une dose supposée, pré-tracer ou masquer une erreur.

07 • Surveillances IDE

RECTO • Évaluer et réévaluer (diapos 41–43)

PARAMÈTRES SELON LE TRAITEMENT

TA / FC : traitements cardiovasculaires ; FR / SpO_2 / vigilance : sédatifs, opioïdes.

Glycémie : antidiabétiques ; douleur : antalgiques ; température : antipyrétiques.

Créatinine, potassium, INR... selon prescription, molécule et contexte.

TRANSMISSIONS CIBLÉES

Données = constats mesurés. Actions = surveillance / alerte / soins. Résultats = réponse et évolution.

OBSERVANCE

Évaluer compréhension, oublis, refus, déglutition, effets gênants.

08 • Erreurs et urgences

VERSO • Causes, prévention, conduite (diapos 44–46)

CAUSES HABITUELLES

Ordonnance ambiguë, abréviation, même emballage, calcul erroné, mauvaise identité, interruption, préparation trop anticipée.

CONDUITE À TENIR

Avant administration : arrêter la préparation à risque, demander clarification.

Après erreur : sécuriser patient, évaluer clinique, alerter médecin / IDE, tracer les faits et déclarer selon procédure.

AUTO-ADMINISTRATION

Possible sous conditions : accord médical, capacité du patient, suivi et traçabilité (arrêté 10/10/2022).

09 • AS, ESI et calculs

RECTO • Collaboration (diapos 39, 47)

COLLABORER ≠ TOUT DÉLÉGUER

L’AS peut aider à la prise non injectable dans les conditions prévues et sous responsabilité IDE.

L’IDE évalue la situation, donne consignes, organise les surveillances. L’ESI agit selon encadrement.

3 FORMULES

Volume (mL) = dose (mg) / concentration (mg/mL). Exemple : 150/50 = 3 mL.

Nombre cp = dose prescrite / dose par cp. Exemple : 500/250 = 2 cp.

Débit mL/h = volume / durée (h). Exemple : 250/5 = 50 mL/h.

RAPPEL

Calcul juste ≠ voie ou dilution autorisée. Vérifier RCP et protocole.

10 • Lexique + mini-quiz

VERSO • Partiels (diapos 48–49)

ABRÉVIATIONS

DCI dénomination commune internationale • PUI pharmacie à usage intérieur • RCP résumé des caractéristiques du produit.

ALD affection de longue durée • MTE marge thérapeutique étroite • ANSM agence du médicament • EIG événement indésirable grave.

TEST RAPIDE + RÉPONSES

1. Les 5 B ? Patient, médicament, dose, voie, moment.
2. Prescription illisible ? Clarifier avant d’administrer.
3. 100 mg à obtenir avec 25 mg/mL ? 4 mL.
4. Erreur constatée ? Sécuriser, alerter, tracer, déclarer.

SOURCES

CM Mme Pillon (09/2026), HAS « 5 B », CSP R.4311-2 / R.4311-5 / R.4312-42, arrêtés 20/02/2026, 26/06/2026 et 10/10/2022. Références détaillées dans le cours A4.